

NOTIFICAR
TODO CASO
SUSPEITO DE
ARBOVIROSES

Dengue: febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e duas ou mais manifestações: náusea/vômito, exantema, mialgia/artralgia, cefaleia/dor retro-orbital e petéquias. Criança com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias sem sinais e sintomas indicativos de outra doença. Considerar prova do laço positiva e leucopenia como manifestações possíveis.

Chikungunya: febre e artralgia ou artrite de início agudo, não explicado por outras condições.^c

Zika: exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de uma ou mais manifestações: febre (podendo ser baixa $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$), hiperemia conjuntival/conjuntivite não purulenta, artralgia/poliartalgia e edema periarticular.

Oropouche: pessoa que resida ou proceda nos últimos 14 dias de área com transmissão autóctone de febre do Oropouche, com febre súbita e duas ou mais manifestações: cefaleia, mialgia, artralgia, tontura, dor retro-ocular, calafrio, fotofobia, náusea e vômito.

- PA em duas posições
→ Enchimento capilar
- Frequência cardíaca
→ Frequência respiratória

Tem sinal de ALARME ou sinal de GRAVIDADE ?

Sinais de ALARME

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômito persistente
- Hipotensão postural e/ou lipotímia
- Hepatomegalia dolorosa
- Sangramento de mucosa
- Aumento progressivo de hematócrito
- Sonolência e/ou irritabilidade
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)

NÃO

Presença de FATORES DE RISCO

- Petéquias ou equimoses espontâneas
- Gestante e puérpera¹
- Menor de 2 anos
- Adulto com mais de 65 anos³
- Risco social
- Hipertensão arterial³, doença cardiovascular³
- Diabetes mellitus, DPOC, doença hematológica crônica, principalmente anemia falciforme, doença acidopéptica e autoimune, doença renal crônica, hepatopatia
- Uso de antiagregante e anticoagulante⁴

NÃO

SIM

Negativa

Prova do Laço²

Positiva

Grupo A

Grupo B

→ Iniciar **hidratação oral IMEDIATA** do Grupo A e B

Hidratação Oral:

Adultos: 60ml/kg/dia

Crianças até 12 anos:

- até 10 kg: 130 ml/kg/dia
- de 10 a 20 kg: 100 ml/kg/dia
- acima de 20 kg: 80 ml/kg/dia

Sendo:

- 1/3 na forma de soro de reidratação oral, e
- 2/3 com líquidos caseiros: água, suco, chá, água de coco etc

Na criança:

- Oferecer de forma frequente e sistemática.
- Manter aleitamento materno

Atenção: 1/3 do volume prescrito deve ser administrado nas primeiras 4 a 6 horas, a partir do atendimento

Acompanhamento Ambulatorial

- Coletar hemograma dengue
- Prescrever medicação sintomática se necessário: antitérmicos e analgésicos (dipirona ou paracetamol)
- Entregar o "Cartão de Acompanhamento⁶ Arboviroses" preenchido e **orientar** o seu uso **Atenção:** Prescrever a hidratação e repouso
- Orientar quais são os sinais de alarme e retorno imediato na presença de um deles
- Orientar **retorno** entre o 3º e 5º dia de sintomas ou a critério médico, com o "Cartão de Acompanhamento Arboviroses"⁶
- Monitorar o resultado do hemograma e **convocar** se tiver hemoconcentração

MATERIAL COMPLEMENTAR



1. GESTANTE E PUÉRPERA ATÉ 14 DIAS



2. PROVA DO LAÇO



3. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL
PACIENTE COM CARDIOPATIA, E
HIDRATAÇÃO ADULTOS > 65 ANOS



4. USUÁRIO DE ANTIAGREGANTE E ANTICOAGULANTE



5. CORREÇÃO DE OUTROS DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS E METABÓLICOS



6. CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE SUSPEITO DE ARBOVIROSES



FEBRE MACULOSA BRASILEIRA E LEPTOSPIROSE SÃO DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PARA ARBOVIROSES

- Questione exposições de risco para essas doenças e considere como hipótese diagnóstica
- Notifique e inicie o tratamento específico

Sinais de GRAVIDADE

- Hipotensão arterial
- Pressão arterial convergente (PA diferencial ≤ 20 mmHg)
- Enchimento capilar lento > 2 segundos
- Pulso rápido e fino
- Desconforto respiratório
- Hemorragia importante: digestiva, respiratória e geniturinária
- Miocardite
- Meningite, encefalite e/ou mielite
- Hepatite com sinais de gravidade
- Insuficiência renal
- Descompensação de doenças de base

SIM

Com sinais de ALARME e sem sinais de Gravidade

Com sinais de GRAVIDADE

Grupo C

Grupo D

→ Iniciar **hidratação IMEDIATA** de acordo com a classificação, enquanto aguarda exames laboratoriais

Acompanhamento

Em leito de internação: até estabilização mínimo de 48h

Acompanhamento

Em leito de UTI: até estabilização mínimo de 48h

Exames Complementares

Obrigatórios: hemograma completo, albumina sérica, transaminases, sorologia, NS1, PCR
Recomendados: raio X de tórax (PA, perfil e incidência de Laurel) e USG de abdome
Outros exames se necessário: glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria, tempo de atividade de protrombina e ecocardiograma
OBS: NS1 e PCR não definem a conduta clínica

Fase de Expansão Adultos e Crianças

Na 1ª hora: Hidratação parenteral imediata
• SF 0,9%: 10 ml/kg

Após 1 hora: Reavaliação clínica
• Sinais vitais, PA, diurese (desejável 1 ml/kg/h)
• BCF em gestante

Na 2ª hora: Repetir hidratação parenteral
• SF 0,9%: 10 ml/kg
• 2º hemograma completo

Reavaliação clínica e laboratorial
• PA em duas posições, sinais vitais, diurese e hematócrito; em gestantes BCF

Se gestante ou puérpera encaminhar para serviços com maternidade

Se necessário o transporte do paciente, manter a hidratação

Melhora clínica e laboratorial. Sinais vitais e PA estável, diurese normal e queda do hematócrito

SIM

NÃO

• Repetir fase de expansão até 3 vezes
• Sem a melhora clínica e laboratorial, conduzir como Grupo D

Fase de Manutenção

Fases de manutenção com soro fisiológico:
• 1ª Fase: 25 ml/kg em 6 horas. Se houver melhora, iniciar 2ª Fase
• 2ª Fase: 25 ml/kg em 8 horas com SF 0,9%
• Verificar necessidade de correção de outros⁵ distúrbios eletrolíticos e metabólicos

Critério de Alta

- Estabilização hemodinâmica durante 48 horas E
- Ausência de febre por 24 horas E
- Melhora visível do quadro clínico E hematócrito normal e estável por 24 horas E plaquetas em elevação E
- Ausência de sintomas respiratórios

Conduta Adultos e Crianças

Reposição volêmica parenteral imediata:

- SF 0,9%: 20 ml/kg em até 20 minutos
- Repetir até 3 vezes conforme avaliação clínica

No transporte do paciente, manter a hidratação

Reavaliação

- Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos
- Reavaliação de hematócrito em 2 horas
- Reavaliação após cada etapa de expansão
- Monitoramento contínuo do paciente

Melhora clínica e de hematócrito:
• Seguir Fase de Expansão do Grupo C

Resposta inadequada com persistência do choque:
• Avaliar hematócrito

Hematócrito em elevação

Hematócrito em queda

Expansores Plasmáticos

- Albumina 0,5-1 g/kg: preparar solução a 5%
Para 100 ml da solução:
25 ml de albumina a 20% em 75 ml de SF 0,9%
• Na falta, usar colóides sintéticos: 10 ml/kg/hora

Com resposta adequada, tratar como Grupo C

Resolução do Choque

Sem sangramento e com outros sinais de gravidade:

- Observar sinais de desconforto respiratório e ICC
- Investigar hiperhidratação
- Diminuir infusão de líquido
- Ministrar diuréticos e drogas inotrópicas, se necessário

Investigar hemorragia e coagulopatia de consumo

Com hemorragia: concentrado de hemácias 10 a 15 ml/kg/dia

Com coagulopatia: considerar plasma fresco 10 ml/kg, vitamina K endovenosa e crioprecipitado (1 U para cada 5-10 kg)

Com sangramento persistente não controlado após correção dos fatores de coagulação e choque, ou trombocitopenia e INR > 1,5 o valor normal: transfusão de plaquetas

Suspender ou **reduzir** a **infusão de líquidos** ao mínimo necessário quando houver:

- Término do extravasamento plasmático
- Normalização da PA, do pulso e da perfusão periférica
- Diminuição do hematócrito, na ausência de sangramento
- Diurese normalizada
- Resolução dos sintomas abdominais